DACON × 오즈코딩스쿨 AI 헬스케어 7 기 해커톤 · 7 조 암파서블

유전자 변이로 암종을 읽는 AI

치료 분기의 첫 단계

환자 한 명의 유전자 4,384 개에 적힌 변이 표기만으로 26 개 암 아형을 분류합니다 .
점수보다 , 왜 그 점수인지를 보여 드립니다 .

0.4700

최종 Public 리더보드 Macro F1

팀 엄태은 (팀장) · 이명석 · 김민준 · 신혜원

2026.11.13 · 13:00 · 20 분

PRESENTATION MAP

여덟 부분으로 말씀드립니다

01 협업

GitHub · 디스코드 · 팀 가이드

02 데이터

6,201 명 · 4,384 유전자 · 26 아형

03 난점 · EDA

희소 · 불균형 · 라벨 충돌

04 선행 연구

점 돌연변이의 천장

05 전처리 · 파생변수

실험으로 검증

06 모델 · 검증

트리 + 텍스트 · Fold-safe

07 결과 · 해석

격차 추적 → 0.4700

08 치료 연결 · 결론

아형 → 치료 분기

매일 기록하고 , 브랜치 → PR → 리뷰로 합쳤습니다

① 계획

팀 가이드

규정 · 데이터 한계 · 논문 10 편 · 진행 일지를 한 페이지에

② 개발

GitHub 브랜치

feat/ 이름 - 주제 → PR → 리뷰 → main. 리뷰에서 규정 위반 2 곳 수정

③ 검증

같은 5-fold

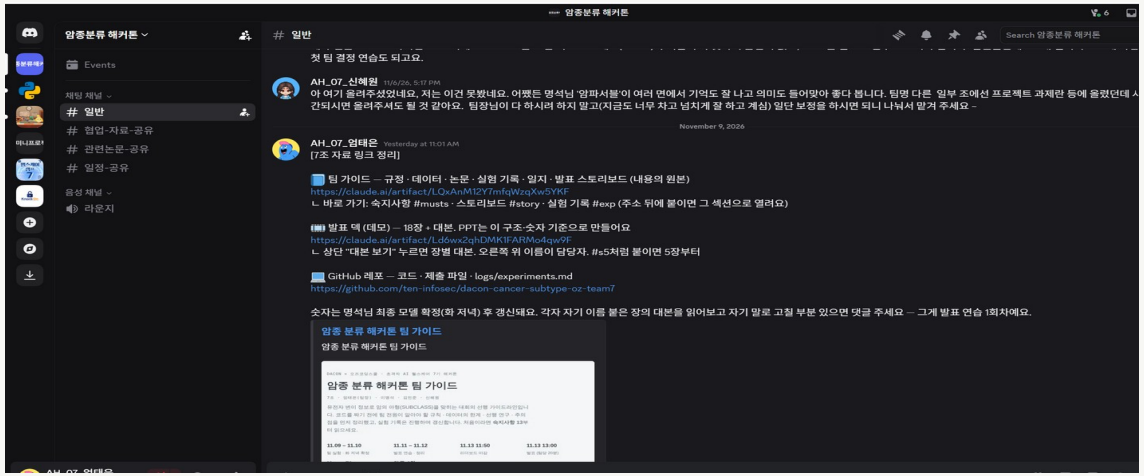
StratifiedGroupKFold · SEED 42 — 같은 시험지로 비교

④ 기록

experiments.md

실험 ID · CV · 리더보드 · 해석 — 기각된 실험도 기록





6,201 명의 유전자 변이로 26 개 암종을 맞힙니다

6,201

train 환자 · test 2,546

4,384

유전자 열 (WT 또는 변이 표기)

26

암 아형 — TCGA 코호트

Macro F1

아형별 F1 의 단순 평균 — 소수 아형도 같은 비중

칸 하나를 읽는 법 — SNV(염기 하나의 치환)

— TP53 R273H = R(원래) · 273(위치) · H(바뀐 아미노산) → 미스센스 (우리 데이터 약 65%)

— R895R 침묵 (26%) · R213* 정지 · L1854fs 프레임시프트

— **환자 98.5% 가 변이 보유 — 그러나 1 인당 평균 35 개 · 중앙값 14 개 / 4,384 → 표의 99.2% 가 WT**

없는 것 — 선행 연구 85–91% 는 이 정보를 더한 수치

— 발현량 · 복제수 변이 (CNV) · 염기서열 문맥 · 임상 정보

— KRAS · NRAS · TERT · GTF2I 등 핵심 유전자 일부

— 입력 자체가 달라 직접 비교 불가

— **외부 데이터 · test-fit 금지 — test.csv 는 예측에만 사용**

모델 설계는 세 가지 데이터 난점에서 출발했습니다

SPARSITY

0.8%

27,185,184 칸 중 변이가 적힌 비율 . 변이 문자열 118,846 종은 거의 전부 한 번씩 → 0/1 + 요약 특성

IMBALANCE

20.7×

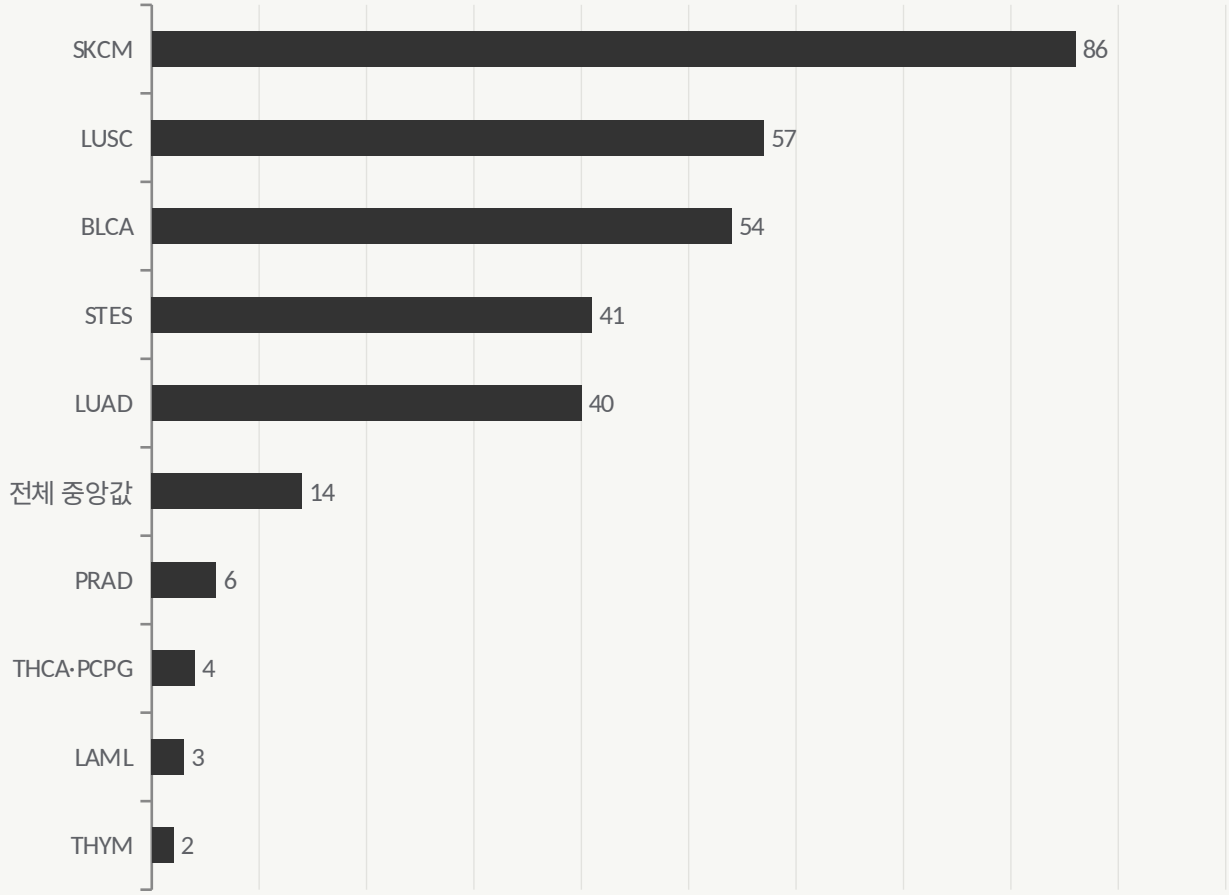
BRCA 786 명 vs DLBC 38 명 . Macro F1 은 아형마다 같은 비중 → 클래스 가중치

CONFLICT

445 쌍

같은 변이 프로필 , 다른 라벨 (KIPAN ↔ KIRC 272 · GBMLGG ↔ LGG 173) — 구조적으로 못 맞힘 → 그룹 CV. 이 구조가 뒤에서 점수 도약의 열쇠가 됩니다

변이 수만으로도 암종이 반쯤 갈립니다



원인이 보인다

자외선 (SKCM) · 흡연 (LUSC·BLCA·LUAD) 은 변이가 많고 , 혈액암 · 내분비암은 적다

긴 꼬리

최대 2,393 개 · 100 개 이상 391 명 (MSI·POLE) · 변이 0 개 94 명 (단서 없음)

모델로 연결

n_mut 한 열로 CV +0.04 (0.338 → 0.380) — 가장 싼 개선

점 돌연변이만으로는 50~67% — 우리는 26 종에서 49%

① 점 돌연변이 (SNV) 만 — 우리와 직접 비교 가능

논문	분류 대상	결과
Soh 2017 · Genome Med	28 종	**49.4%**
CPEM 2019 · Sci Rep	31 종	46.9%
DeepGene 2016 · mClass 2018	12 종	65.5% · 67.5%
TumorTracer 2015	10 개 부위	66.6% · 외부 46%
우리 (7 조)	**26 종**	**49% · Macro F1 0.49**

② 다른 정보 추가 — 참고용 (우리 데이터엔 없음)

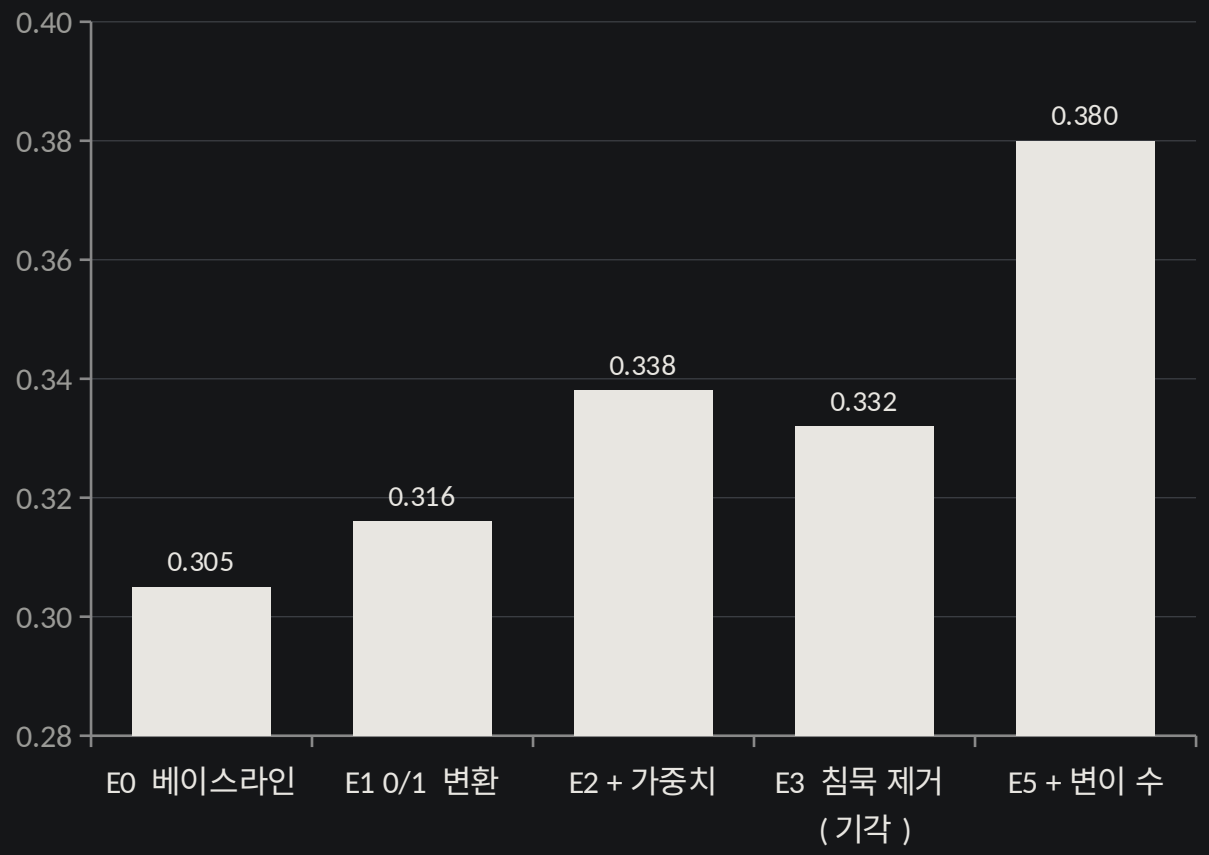
논문	추가 정보	결과
Soh 2017	+ 복제수 변이	88.4%
CPEM 2019	+ 변이율 · 복제수	84.1%
Jiao 2020 · Nat Commun	전장 유전체	91% (운전자만 F1 0.33)
OncoNPC 2023 · Nat Med	패널 + 임상	확신도≥ 0.9 F1 0.94

— 분류 대상 10 개 안팎에서 47~67% → 26 개 암종에서 49% 는 같은 선 (클래스가 많을수록 어려움)

— 정보가 제한된 조건에서 ' 어디까지 , 왜 ' 를 설명 — 1 차 패널만으로 암종 후보를 좁히는 안전망

— Jiao: 운전자 변이만 쓰면 F1 0.33 → 승객 (침묵) 변이도 신호라 지우지 않음

전처리 : 왜 했고 , 얼마나 올랐나 — 0.305 → 0.380



— P1 문자열 → 0/1: 118,846 종 번호 매기기는 의미 없는 순서 (+0.011)

— P5 클래스 가중치 : 38 명 DLBC 도 786 명 BRCA 와 같은 비중 (+0.022)

— P3 침묵 변이 제거 → 기각 (−0.006): 승객 변이에도 신호 (Jiao 2020)

— **P4 환자당 변이 수 한 열 (+0.042) — 가장 싼 개선**

— P0 test 빈칸 237 개 → WT: 형식 처리일 뿐 , 분포는 보지 않음

파생변수 : 논문 아이디어를 실험으로 검증 — 0.380 → 0.450

특성	근거	CV 변화	판정
변이 유형별 개수 · 비율 (침묵 · 미스센스 · 정지 ·fs)	CPEM 변이율	**+0.024**	**채택 — 최대 단일 상승**
아미노산 치환 12 패턴 + 6 그룹 전이 72 열	TumorTracer 근사	+0.009 / +0.020	채택
드라이버 157 유전자 2 채널 (314 열)	Vogelstein 20/20	+0.012	채택 → LB 과적합 확인
신호경로 10 개 변이 부담 (20 열)	Sanchez-Vega 2018	+0.004	안정성용
아형별 임계값 보정	—	−0.008	기각 (중첩 검증)
중복 토큰 수 · 계층 후처리	데이터 관찰	+0.001 · −0.005	기각

유전자 열 없이 요약 특성 407 열만으로 CV 0.404 — 점수의 대부분은 환자 단위 요약에서 나온다

변이 문자열을 텍스트로도 읽었습니다

한 칸 → 토큰 : BRAF 열의 값 V600E

— gene_BRAF — 어느 유전자가 고장났나

— mut_V600E — 정확히 어떤 변이인가

— event_BRAF_V600E — 조합

— 환자 한 명 = 문서 한 장 → TF-IDF → LinearSVC (어휘는 fold 안 train 에서만)

왜 두 표현인가

트리 = 숫자의 비선형 조합 · 텍스트 = 문자열 규칙 . 서로 다른 실수 → 섞으면 상쇄

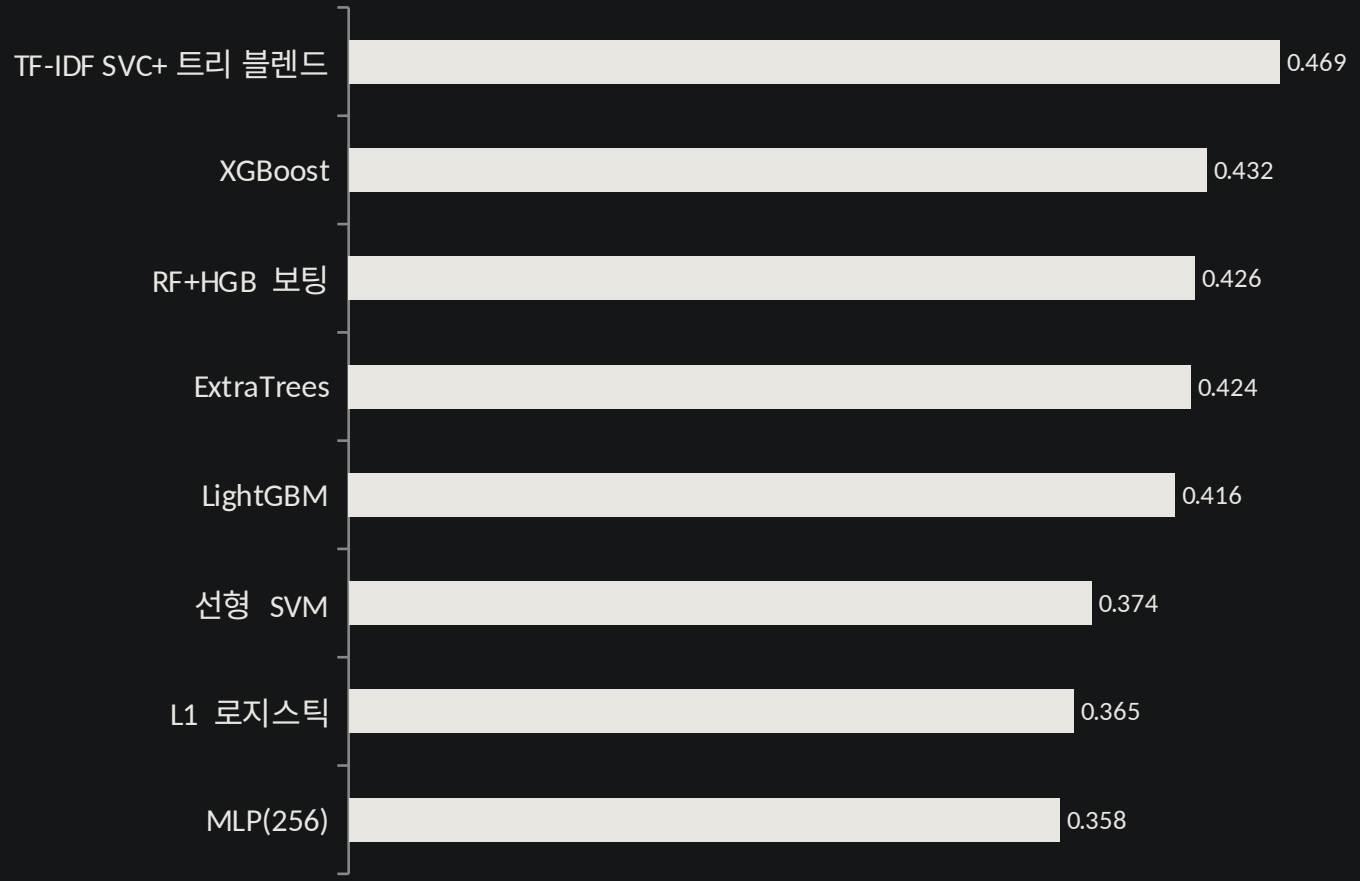
검증

치환 20×20 + 6 그룹 특성 리더보드 0.354 (단일 최고) · 텍스트와 블렌드는 다음 장

기각

5 층 토큰 ·char 3–5gram: OOF 0.475 → LB 0.350. 세밀할수록 train 을 외운다

모델 8 종을 같은 시험지로 비교했습니다



— 트리 계열 0.42~0.43 몰림 — 튜닝 (RandomizedSearch) 은 − 0.018 로 효과 없음

— 모델 종류보다 특성이 점수를 만든다

— 최종 : 트리 9 개 + 텍스트 SVM 에 kNN 15% · 변이 토큰 kNN 10% · 나이브 베이즈 3%

— LightGBM· 로지스틱도 시험 — 트리 · 선형과 겹쳐 블렌드 효과 없음 → 제외

— GPU 없음 · Colab CPU 에서 전부 재현 가능

Fold-safe: test 는 예측할 때만 열었습니다

GROUP

프로필 단위 분할

같은 변이 프로필 (445 쌍) 은 같은 fold 에 — 외워서 맞히는 부풀림 차단

STRATIFIED

아형 비율 유지

26 개 아형 불균형을 fold 마다 같게 · DLBC 는 fold 당 7 명

FIT IN FOLD

fold 안 train 만 fit

유전자 필터 · TF-IDF 어휘 · 메타 모델 전부 . 리뷰로 train+test fit 2 곳 수정

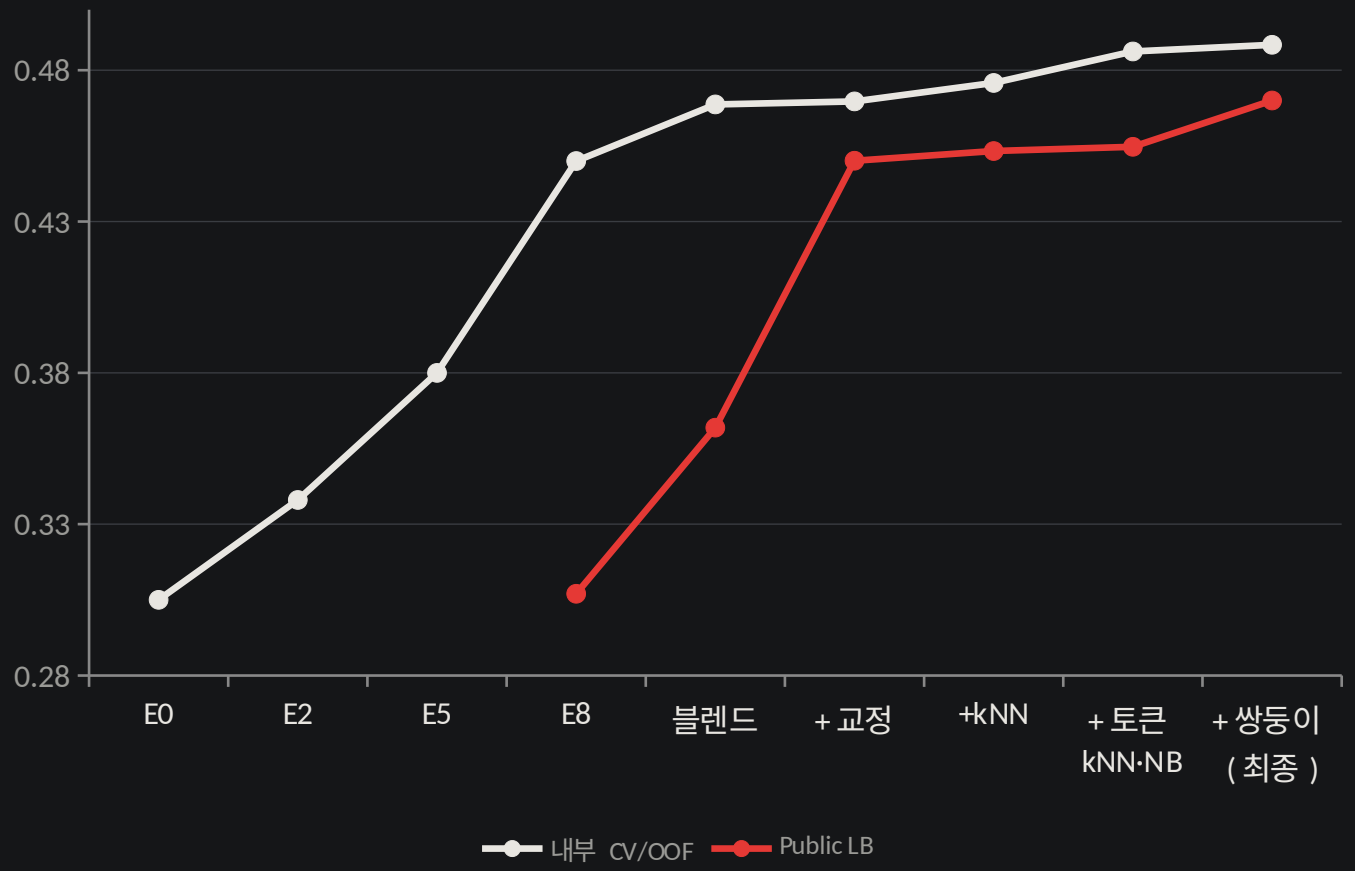
TEST

transform 만

분포 · 통계 보지 않음 · 빈칸 237 개는 형식 처리 (WT) 만

모든 실험 = 같은 분할 · SEED 42 — 팀원 간 점수를 비교하려면 시험지가 같아야 합니다

내부 0.488 · 리더보드 0.4700



0.4700

최종 Public 리더보드 Macro F1

+0.086

형제 라벨 교정 한 번의 상승 (전체 최대)

0.345 → 0.4700

격차 추적이 만든 상승

격차를 추적했더니 데이터 구조가 보였습니다 — 0.345 → 0.4700

1 **공통 격차 − 0.1**

모든 팀원 모델이 CV 보다 0.08~0.14 낮다 → 공통 원인은 test 분포 차이

2 **가설 A 설정 → 기각**

같은 특성 + 규제 설정 제출 → 0.305 변화 없음

3 **가설 B 특성 → 확정**

거친 특성 0.345~0.354 vs 세밀한 특성 0.305~0.319 — 세밀할수록 train 을 외운다

4 **다른 표현 섞기**

트리 (숫자) 0.6 + 텍스트 (문자열) 0.4 블렌드 → 0.362

5 **구조의 발견 +0.086**

test 266 명이 train 과 프로필 일치 . train 내 동일 프로필 422 그룹 전부 ' 같은 환자 , 다른 코호트 라벨 ' → 형제 라벨로 222 명 교정 → 0.448

6 **전담 분류기 +0.002**

혼동쌍 전담 분류기 (LUAD ↔ LUSC·HNSC ↔ LUSC, OOF 검증 채택) → 0.4501

7 **닮은 환자의 투표 +0.005**

kNN(닮은 유전자) · 토큰 kNN(정확히 같은 변이) · 나이브 베이즈 — 트리 · 텍스트와 다른 실수 → 0.4547

8 **구조 한 번 더 +0.015**

KIRC 332 명 ·LGG 226 명 전원 쌍둥이 보유 → 쌍둥이 없으면 KIRC·LGG 제외 · 새 모델 비중 축소 → 0.4700

하루 4 회 제출 = ' 점수 내기 ' 가 아니라 가설을 가르는 실험 — 그 추적이 0.345 를 0.4700 으로 만들었습니다

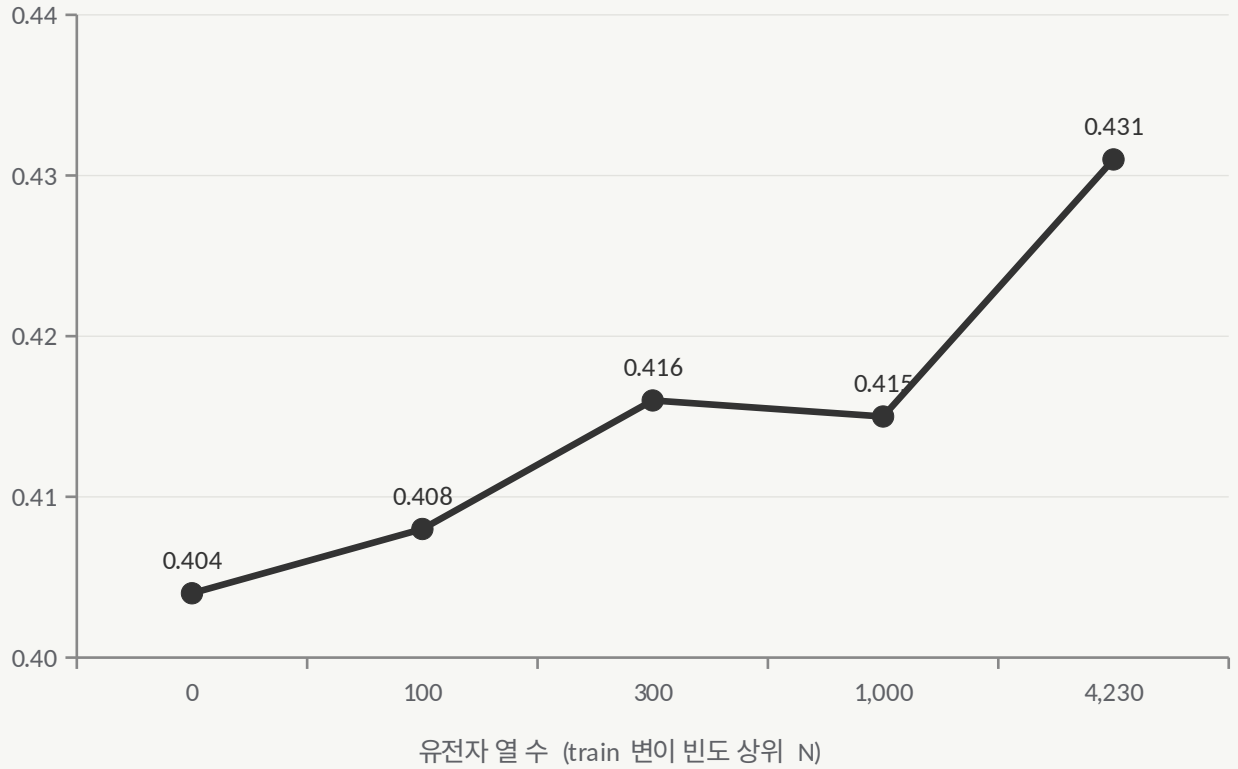
약한 아형은 모델이 아니라 데이터의 한계입니다



아형	F1	이유
SARC	**0.16**	복제수 변이 주도 — 점 돌연변이에 안 보임
PCPG	**0.27**	변이 중앙값 4 개 · 융합 주도
THYM	**0.30**	30 명 변이 0 · GTF2I 누락
KIPAN	**0.32**	KIRC 와 라벨 중복 → test 에선 형제 교정으로 해결
HNSC	**0.35**	LUSC 와 흡연 공유 → 전담 분류기
PRAD	**0.37**	융합 (TMPRSS2-ERG)· 복제수 주도
잘 맞는 암	**0.69–0.88**	SKCM 0.88·COAD·ACC·THCA — 지문 유전자가 있는 암 . DLBC 는 0.46 회복

AI 알고리즘의 실패가 아니라 , 데이터 (SNV) 와 암의 생물학적 본질 (CNV· 융합) 사이의 도메인 미스매치

경량화 : 유전자 300 개면 충분합니다



0.404

요약 특성만 (유전자 0)

점수의 대부분은 환자 단위 요약 407 열에서

0.416

상위 300 + 요약

열 1/6 · 학습 6 배 빠름 · 실제 병원 패널 규모

0.431

전체 4,230

+0.015 의 대가는 느린 학습과 과적합 위험

확신도 높은 환자부터 , 치료 분기의 첫 단계를 돕습니다

① 패널 결과 → ② 아형 + 확신도 → ③ 확신도 게이트 → ④ OncoKB 치료 후보 → ⑤ 의료진 판단

아형 (우리 라벨)	변이	근거	치료 분기
SKCM 흑색종	BRAF V600E	Level 1	BRAF+MEK 억제제 단독 — 승인 근거
COAD 대장암	BRAF V600E	Level 1	단독 실패 (EGFR 피드백) → EGFR 억제제 병용
BRCA 유방암	PIK3CA	Level 1	Alpelisib
GBMLGG 뇌교종	IDH1/2 · BRAF V600E	Level 1	Vorasidenib · Dabrafenib+Trametinib
BLCA 방광암	FGFR3	Level 1	Erdafitinib
KIPAN 유두상 (KIRP)	MET	임상시험	Cabozantinib (PAPMET)

65% ↓

OncoNPC: AI 예측 암종에 맞춘 치료군 사망 위험 (HR 0.348, 95% CI 0.21–0.57) · 표적치료 기회 2.2 배

17.2 vs 11.4 개월

삼성서울 SCLC 361 명 : 분자 아형별 Chemo-IO 반응군 vs 내성군 (HR 0.49, Exp Mol Med 2026)

점 돌연변이로 잡히는 것만 표시 — HER2 등 증폭 (CNV) 근거 치료는 별도 검사 필요 · Level 은 oncokb.org 기준 · 개념 시연이며 최종 판단은 의료진

천장 안쪽에 닿았고 , 왜 그 점수인지 압니다

0.305 → 0.488

Build — 전처리 + 파생변수 + 블렌드 , 기각 실험도 기록

0.4700

Reality check — 격차 추적 (특성→다양성→구조) 의 결과

6 / 26

Interpret — 26 개 중 약한 아형 6 개는 데이터의 한계로 설명

한계

— 라벨이 겹치는 445 쌍은 구조적으로 못 맞힘

— 복제수 · 발현 없이 SARC·PRAD·PAAD 는 어려움

— test 분포 차이로 CV 는 리더보드를 과대평가

다음 단계

— 확신도 기반 판정 보류 + 확률 보정

— 300 유전자 경량 모델로 서비스 시나리오 검증

— 복제수 변이가 있는 데이터로 외부 검증

만드는 것보다 ' 만든 것을 이해하고 설명하는 것 ' — 감사합니다 · github.com/ten-infosec/dacon-cancer-subtype-oz-team7